PLANO DE ANÚNCIOS PARA CONSULTÓRIO · VERSÃO DE 04/11/2026

Como eu faria seus anúncios de Urologia

Plano para quem tem consultório próprio, continuando o carrossel: a conta, a verba, as campanhas, os criativos e o combinado com a recepção, para urologia.

1 A conta da consulta, antes de qualquer anúncio

Clínica não compra conversa. Clínica compra paciente sentado na cadeira. Por isso a primeira coisa que eu faria é esta conta, com os seus números.

1 O valor da consulta que você cobra

2 menos o que ela custa para você (equipe, aluguel, imposto) = o que sobra

3 Valor da consulta ÷ o que sobra = quanto cada R$ 1 de anúncio precisa voltar para empatar

EXEMPLO, NÃO É NÚMERO SEU

Consulta de R$ 400, sobram R$ 200	**cada R$ 1 precisa voltar R$ 2**
Com 25% de desconto: consulta de R$ 300, sobram R$ 100	**cada R$ 1 precisa voltar R$ 3**
R$ 1.000 de verba a R$ 10 por conversa = 100 conversas	**16 consultas realizadas, R$ 6.400 em consultas de R$ 400 (se 40% agendam e 40% comparecem)**

Seus números: consulta R$ _____ · sobra R$ _____ · cada R$ 1 precisa voltar R$ _____

Os 40% são benchmark de mercado (funil 40/40/40, do método de Pedro Sobral): de 100 conversas, 40 agendam, 16 comparecem e 4 fecham tratamento ou procedimento. Serve só para abrir a conversa. Com 60 a 90 dias de campanha, vale o número da sua conta, e só ele.

O que entra na conta nesta especialidade

É comum o paciente de urologia adiar a primeira consulta. Trate isso como hipótese e confirme na sua agenda. Conte a consulta, o exame que você faz e o retorno. O paciente que marca e some é o retorno que a recepção precisa recuperar.

2 Onde colocar a verba

Google

vai quem tem urgência. O paciente já está procurando e escolhe quem aparece e responde primeiro.

Meta (Instagram e Facebook)

vai quem tem ticket e precisa de confiança. Antes de vender o preço, eu preciso vender o médico.

Notoriedade

médico já conhecido na cidade rende no Google mesmo com ticket alto.

META PESA MAIS

Tem homem que adia e não pesquisa o nome do médico. Ele precisa ser tirado da inércia por um vídeo que fale a dúvida que ele não faz em voz alta. O Google pega quem já está com o sintoma, como ardência, sangue na urina ou cólica. Eu colocaria a maior parte na Meta e manteria o Google enxuto, em sintoma e em cidade.

A fatia exata de cada lado eu só fecho com 60 a 90 dias de dado da sua conta. Aqui está o ponto de partida.

3 As 3 campanhas do Google

Volume de busca e custo por clique eu não medi para a sua cidade. Tudo abaixo é para testar, não é dado. Eu começaria em correspondência exata, e abriria para frase só se a exata não gastar a verba.

1. Nome do médico

Quem já ouviu falar de você e vai conferir. Teto de R$ 30 por dia.

- dr. / dra. [seu nome]
- [seu nome] [cidade]
- [nome da clínica] [cidade]

2. Especialidade + cidade

Quem já sabe qual médico procura e está comparando.

- urologista [cidade]
- urologista particular [cidade]
- consulta com urologista [cidade]
- check-up urológico [cidade]
- urologista perto de mim

3. Sintoma

Quem ainda não sabe qual médico resolve. Ele pesquisa o que sente.

- ardência ao urinar
- sangue na urina
- cólica renal
- pedra no rim
- infecção urinária no homem
- levantar à noite para urinar
- jato de urina fraco

Negativar de saída: "chá", "remédio caseiro", "comprar sem receita", "grátis", "SUS", "vídeo".

> Termos de saúde sexual podem ter restrição de política no Google e na Meta. Confirme as regras vigentes antes de subir qualquer um deles.

Destino do clique: o WhatsApp da recepção ou uma página curta com preço, forma de pagamento e endereço. O clique no botão de WhatsApp é a conversão que eu marco.

4 Público e sequência na Meta

> **Público**
>
> Homens adultos da cidade e do raio, e um público à parte: a esposa ou companheira que empurra o marido para a consulta. O criativo nunca fala como se soubesse a condição de quem vê. Ele descreve a situação e convida.

MÊS 1

70% no topo

70% da verba vai para quem ainda não conhece o seu nome, com vídeo que tira dúvida. Os 30% restantes vão para o anúncio de consulta, com preço e forma de pagamento, para quem já viu o vídeo.

Os dois primeiros vídeos do mês são o que acontece na primeira consulta, passo a passo, e a pergunta do toque retal.

MÊS 2 EM DIANTE

60% em remarketing

60% da verba vai para quem já conhece você: quem chamou no WhatsApp (180 dias), quem visitou o site (90 dias) e quem assistiu aos vídeos (30 dias). O topo continua rodando com o resto.

Quem chamou e não marcou vê um vídeo discreto sobre o que esperar na consulta, com valor. Quem assistiu ao vídeo vê o anúncio de consulta com horários.

Eu não mexo numa campanha em menos de 72 horas e olho o mês, não o dia. Eu reporto duas medidas lado a lado: conversa iniciada e segunda mensagem enviada. Só a primeira infla.

5 3 ângulos de criativo

Cada um filtra um paciente. Atenção sem filtro traz curioso, e curioso encarece a conversa.

Levantar de madrugada

"Tem homem que acha normal levantar duas vezes de madrugada para urinar. Eu explico quando vale conversar com o urologista."

Vídeo do médico. Filtra o paciente que aceita o sintoma como idade.

Primeira consulta sem susto

"O que acontece na primeira consulta de urologia, passo a passo."

Reel ou carrossel. Tira o medo do desconhecido, que é o maior freio.

Para quem convive com ele

"Ele adia há anos. Como falar com ele sobre ir ao urologista."

Reel ou carrossel para esposa e filha. Abre um público que decide e marca.

6 5 dúvidas de paciente para virar conteúdo

1. "Toque retal dói? É obrigatório?"
2. "Com que idade eu devo começar a ir ao urologista?"
3. "Pedra no rim sai sozinha?"
4. "Infecção urinária no homem é comum?"
5. "Vasectomia dói? Dá para reverter?"

Cada dúvida vira um vídeo ou carrossel. Toda resposta com número ou critério precisa de fonte que você possa citar. Sem fonte, tira o número e fica o raciocínio.

7 O combinado com a recepção

Eu trabalho com 20 minutos como limite de resposta: quem tem dor costuma chamar mais de um consultório e fecha com quem responde primeiro e já oferece horário.

Quem responde	Em quanto tempo	O que a IA pode fazer sozinha

A primeira resposta, por escrito

Repetir o que a pessoa pediu, informar o valor e oferecer dois dias e horários. Cadastro e reserva vêm depois da escolha.

Pergunta inicial: "É primeira consulta ou retorno? Prefere um horário mais discreto?"

Urgência e encaixe

Dor muito forte com vômito, febre ou impossibilidade de urinar: a recepção não marca. Orienta pronto-socorro.

Muito paciente de urologia tem vergonha de explicar por mensagem. A recepção não pede detalhe do sintoma. Oferece dois horários e a opção de uma ligação.

Automático pode ser o aviso de recebimento, a pergunta inicial e o lembrete de horário. Preço, horário e qualquer orientação de saúde saem de uma pessoa ou de um texto que você já aprovou.

8 O que eu NÃO faria, pelo conselho

Base: Resolução CFM 2.336/2023, a vigente. Ela permite informar preço, forma de pagamento e desconto. Continua fora:

- Promessa de resultado, em qualquer forma.
- Antes e depois.
- Nota, estrela ou print de avaliação.
- Chamar alguém de especialista sem o RQE registrado.
- Escassez que não existe. "Últimos horários" só se a agenda estiver fechando de verdade.

Nesta especialidade, o risco mais comum

- Texto que insinua a condição de quem lê, como "você sofre de disfunção?".
- Promessa de desempenho, de cura ou de resultado.
- Antes e depois, e print de avaliação com nota ou estrela.
- Colocar "urologista" no título sem o RQE. Sem ele, use "médico" e descreva a área em que atende.

Antes de subir qualquer anúncio, o texto passa por revisão. Este plano não substitui a leitura da resolução pelo responsável técnico.

E antes da conversa chegar?

O plano cuida do anúncio e da recepção. O Raio-X olha o passo anterior: como o seu consultório aparece hoje no Google e na IA. Leva poucos minutos.

Fazer o Raio-X do meu consultório